

Patiente de 70 ans, connue pour une fibrillation auriculaire anticoagulée, une hypercholestérolémie sous traitement de statine, diabétique non-insulino-dépendante et hypertension traitée, se présente à la consultation pour des douleurs au pied droit depuis 6 mois et une plaie du talon depuis 2 mois, qui ne guérit pas malgré des soins locaux. Ses autres médicaments Il n'y pas de pouls palpables au pied à l'examen clinique mais présents en pédieux. Un bilan angiologique a mis en évidence un ABI à 0.2 à gauche et 0.7 à droite avec des flux monophasiques faibles en tibial postérieur à gauche. Les plethysmographies au gros orteil sont de 25 à gauche et 80 à droite. Présence d'une grande veine saphène de 4 mm de diamètre à gauche.

L'angio-CT scan effectué montre: athéromatose mais pas de sténoses significatives à l'étage aorto-iliaque. A droite, sténose de l'artère fémorale commune et de l'artère fémorale superficielle proximale. A gauche, occlusion de l'artère fémorale superficielle depuis son origine ainsi que de l'artère poplitée. En distalité, seule l'artère tibiale postérieure est perméable depuis mi-jambe et continue jusqu'à l'arcade plantaire.

Quelle proposition thérapeutique vous semble la plus adaptée:

- A. Entraînement à la marche
- B. Angioplastie et stenting de l'artère fémorale superficielle par voie endovasculaire
- C. Thrombolyse intra-artérielle in situ
- D. Pontage fémoro-tibial postérieur du MIG**
- E. Amputation de la jambe gauche selon Burgess

Un patient de 80 ans, connu pour un pontage fémoro-tibial antérieur veineux inversé du MIG confectionné il y a 5 ans arrive aux urgences avec un membre inférieur G douloureux et froid depuis 2 jours. Ses médicaments sont de l'aspirine, une statine, un beta-bloquant, un diurétique et un anti-inflammatoire. Le status clinique met en évidence un pied blanc et froid sans aucun pouls périphérique palpables gauches hormis en fémoral. Il n'y pas de déficit sensitif ou moteur. La radiographie du thorax est sans particularité. L'ECG met en évidence un rythme régulier sans modification du segment ST. Un bilan angiologique montre une plethysmographie à 0 à gauche et 75 à droite. Le flux est biphasique en fémoral commun gauche, l'artère fémoral profonde est perméable. Le pontage est occlus et il y a une reprise de l'artère tibiale antérieure distalement au pontage occlus, puis elle est perméable jusqu'à la cheville. Un angioCT confirme l'occlusion du pontage. Il n'y a pas de sténose significative sur les artères iliaques et sur l'artère fémorale commune.

Quelle attitude est la plus correcte ?

- A) Thrombolyse intra-artérielle**
- B) Amputation de la jambe
- C) Angioplastie et stenting du pontage
- D) Nouveau pontage fémoro-tibial antérieur prothétique
- E) Anticoagulation orale

